

Лекар, пациент, екип и закон

Хронично болният пациент, модели на взаимоотношение, междупрофесионални отношения и правна отговорност на лекаря

Упражнение 4 · СММЕ — I част · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра „Социална медицина и обществено здраве“

Четири въпроса за днешното упражнение

1. Хронично болният пациент
2. Модели на взаимоотношението лекар – пациент
3. Междупрофесионални отношения
4. Правна отговорност на лекаря

Хронично болният пациент

Хроничната болест променя логиката на грижата

Измерение	Остра грижа	Хронична грижа
Време	Ограничен лечебен епизод	Продължително или пожизнено проследяване
Цел	Овластяване на опасността, възстановяване	Контрол, запазени функции, приемливо качество на живот
Пациент	Получава помощ, изпълнява краткосрочен план	Взема ежедневни решения, извършва голяма част от грижите
Лекар	Диагностицира и действа своевременно	Поддържа отношението, договаря цели, координира

Болест е диагнозата; **боледуване** е преживяването ѝ. Добрата грижа обхваща и двете.

Механизми на справяне с болестта

Насочени към проблема

Търсене на информация, самонаблюдение, промяна на режима, планиране, търсене на помощ.

Насочени към емоцията

Дистанциране, отричане, отвличане на вниманието, споделяне, религиозна опора.

Насочени към смисъла

Преподреждане на целите, нови роли, ценности отвъд болестта.

Диагнозата разделя живота на „преди“ и „след“. Задачата на лекаря е да подкрепи приспособяването, а не да оценява „правилната“ реакция.

Чести реакции и отговор на лекаря

Реакция	Как изглежда	Професионален отговор
Отричане	„При мен не е толкова сериозно.“	Постепенна информация; проверка на опасните пропуски
Гняв	Обвинения към екипа и близките	Назоваване на емоцията, без лично засягане
Регресия	Пасивност, пълна зависимост от другите	Запазване на уменията, малки договорени задачи
Безнадеждност	„Няма смисъл да се лекувам.“	Оценка за болка, депресия, риск от самонараняване

Реакциите се повтарят при всяко ново усложнение и не са морален дефект.

Автономност, придържане и терапевтичен товар

Релационна автономност

Зависимостта от апарат, лекарства или близки не отнема правото на избор. Изборът обаче може да е повлиян от вина, страх или натиск.

Терапевтичен товар

Лекарства, измервания, прегледи, пътуване, разходи. Колко още може да понесе този човек?

Придържане, не послушание

Непридържането може да е неволно или съзнателно. Първо се търси причината, а не виновният.

Споделена отговорност

Лекарят — за обоснован и разбираем план; пациентът — за честна обратна връзка; системата — за достъпна грижа.

Семейството: подкрепа, товар и граници

Какво носи семейството

- Ежедневна грижа и наблюдение.
- Познание за живота на пациента.
- Емоционална и практическа опора.

Какви са рисковете

- Говорят вместо пациента.
- Свърхзакрила, загуба на умения.
- Изтощение на основния грижещ се.
- Пренебрегване или насилие.

Пациентът определя кои близки участват и какво узнават.

Казус 1 · Докторът ми е стар приятел

Пациент с новооткрита артериална хипертония се познава с лекаря си от детството. Два месеца след началото на лечението налягането е по-високо. Пациентът пие лекарството само когато сам прецени и през смях казва: „Знаем се от години — просто ми предпиши по-силни хапчета.“

- Какво обяснява поведението му: недисциплинираност или модел на болестта?
- Кой модел на отношение е подходящ?
- Помага или пречи приятелството?

Модели на взаимоотношението лекар – пациент

Сас и Холендер: три степени на участие

Модел	Разпределение на ролите	Типична ситуация
Активност – пасивност	Лекарят действа, пациентът не може да участва	Реанимация, кома, обща анестезия
Ръководство – сътрудничество	Лекарят води, пациентът съзнателно следва	Остро заболяване с ясен стандарт на лечение
Взаимно участие	Разпределени задачи и решения	Хронично заболяване, рехабилитация, промяна на поведението

Моделът следва състоянието на пациента и се променя заедно с него.

Емануел и Емануел: четири модела

Модел	Ценности на пациента	Роля на лекаря	Автономност като
Патерналистичен	Обективни, определени от лекаря	Настойник	Съгласие с „най-доброто“
Информативен	Известни и устойчиви	Технически експерт	Избор след информиране
Интерпретативен	Неясни, нуждаят се от изясняване	Съветник	Самопознание
Обсъждащ	Подлежат на обсъждане	Учител, събеседник	Морално саморазвитие

В една среща могат да се появят елементи от повече от един модел.

Вийч: четири модела и други разновидности

Модел	Същност	Основен риск
Инженерен	Лекарят е учен, който предава фактите	Ценностите на пациента остават извън разговора
Свещенически	Лекарят решава от позиция на морален авторитет	Патернализъм
Колегиален	Двама равни с обща цел	Илюзия за равенство и общи интереси
Договорен	Договорени права и задължения	Минимализъм: „само каквото е уговорено“

Учебникът добавя: **пазарен** (здравето като стока), **съглашение** (обещание за вярност), **приятелство** (размити граници).

Патернализъм и професионална граница

Силен патернализъм

Ограничава способен и информиран пациент. Скриване на диагноза, пренебрегнат отказ: не се оправдава.

Слаб патернализъм

Защитава човек с нарушена способност за конкретното решение; трае, докато основанието съществува.

- Пациентът може да откаже предложеното лечение, но не може да изиска вредно или ненужно.
- Лекарят може да откаже лечение при липса на доверие, но никога спешна помощ (Кодекс, чл. 11, 12).

Споделено вземане на решения

1

Има избор

2

**Разумни
възможности**

3

**Какво е важно
за пациента**

4

**Препоръка с
основания**

5

**План и
проверка**

- 33, чл. 86, ал. 1: право на ясна информация на достъпен език и на повече от едно медицинско становище.
- 33, чл. 190, ал. 1: свобода на действия и решения според квалификацията, стандартите и медицинската етика.

Препоръка без отнемане на избора.

Междупрофесионални отношения

Колегиалност по Кодекса за професионална етика

Член	Съдържание
чл. 40	Колегиалността е основен дълг, който се спазва, като се уважават интересите на болния.
чл. 41	Морална помощ; забрана за клевета и злословене; разногласията не са предмет на публични полемики.
чл. 42	Недостойно е колега да бъде zlepоставян чрез критика на лечението или на личността му.
чл. 46	Етичните спорове между лекари се решават от комисиите по професионална етика на БЛС.
чл. 49	Лекарят помага на заболял колега и сътрудничи с лекуващите го.

Консултация, консилиум и приемственост

Консултация

Търси се, когато състоянието го налага (чл. 35). Консултантът съобщава резултата на лекуващия (чл. 36, 45).

Консилиум

При трудности в диагнозата и лечението; решението при общо съгласие е задължително (чл. 38).

Приемственост

Пълна информация при оттегляне (чл. 24); промяна в отсъствие на лекуващия се документира (чл. 50).

Пропуските при предаване на пациента са честа причина за предотвратима вреда.

Лекар, медицинска сестра и екип

Различни роли, общ пациент

Всяка професия има собствена компетентност, съсловна организация и етичен кодекс.

Право на глас

Всеки член на екипа може да спре процедура при риск за безопасността.

Ясни назначения

Писмени, четливи, проверими. Съмнението се изяснява, не се изпълнява мълчаливо.

Уважение

Публичното унижаване пред пациенти разрушава доверието и прикрива грешките.

Колегиалност не означава прикриване

Положение	Риск	Професионално поведение
Колега търси помощ	Непълнен преглед без документация	Формална консултация и проследяване
Колега научава диагнозата	Разпространяване от любопитство	Същата поверителност като за всеки пациент
Болестта засяга работата	Прикриване или автоматично отстраняване	Индивидуална оценка, пропорционално ограничаване
Непосредствен риск	Отлагане в името на колегиалността	Защита на пациентите и помощ за лекаря

Казус 2 · Хирургът с тремор

Опитен хирург забелязва фин тремор на ръката и моли приятел невролог да го прегледа неофициално след работа. Прегледът поражда съмнение за прогресиращо заболяване. Хирургът отказва документиране и допълнителни изследвания. На следващия ден има сложна планова операция.

- Какъв е статутът на неформалния преглед?
- Как се съчетават тайната, колегиалността и безопасността на пациентите?
- Какво трябва да направи неврологът?

Правна отговорност на лекаря

Едно деяние, няколко вида отговорност

Вид	Основание	Кой я реализира
Съсловна (дисциплинарна)	ЗСОЛЛДМ, чл. 37–42; Кодекс	Комисия по професионална етика на БЛС
Административна	ЗЗ, чл. 221, 229	Контролни органи, ИА „Медицински надзор“
Гражданска договорна	ЗЗД, чл. 79–82	Съдът по иск на пациента
Гражданска деликтна	ЗЗД, чл. 45–53	Съдът по иск на пострадалия
Наказателна	НК, чл. 122–145	Прокуратурата и съдът
Трудова	КТ, чл. 186–190; 203–212	Работодателят; съдът

Съсловна и административна отговорност

Съсловна (ЗСОЛЛДМ)

Неспазване на Кодекса или на правилата за добра медицинска практика (чл. 37, ал. 1). Наказания (чл. 38): порицание; глоба от една до пет минимални работни заплати; заличаване от регистъра от 3 месеца до 1 година.

Административна (ЗЗ)

Глоба за нарушение на закона и подзаконовите актове (чл. 229). Глоба или имуществена санкция за лечебно заведение, нарушило права на пациента (чл. 221).

Контролът върху добрата медицинска практика е на ИА „Медицински надзор“ съвместно с БЛС (ЗСОЛЛДМ, чл. 37, ал. 2).

Гражданска отговорност: договор и деликт

Договорна (ЗЗД)

- Неточно изпълнение на поето задължение (чл. 63, 79).
- Без отговорност при невиновна невъзможност (чл. 81).
- Обезщетение за предвидимите вреди; за всички преки вреди при недобросъвестност (чл. 82).

Деликтна (ЗЗД)

- Вреди, виновно причинени другиму; вината се предполага (чл. 45).
- Лечебното заведение отговаря за вредите от своя лекар (чл. 49).
- Неимуществени вреди по справедливост (чл. 52); солидарност (чл. 53).

Давност: 5 години (чл. 110); при деликт тече от откриването на дееца (чл. 114, ал. 3).

Наказателна отговорност: Наказателен кодекс

Член	Състав
чл. 122, 133	Смърт, тежка или средна телесна повреда по непредпазливост (обща състави)
чл. 123, 134	Смърт или телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие, източник на повишена опасност
чл. 137, 138	Оставяне без помощ на безпомощно лице, включително от лице, длъжно да се грижи за него
чл. 141	Медицинско лице, което без уважителна причина не се притече на помощ на болен или родилка
чл. 145	Противозаконно разкриване на професионална тайна

Вина: умисъл или непредпазливост; непредпазливото деяние е наказуемо само когато законът го предвижда (чл. 11).

Лекарят като работник, заведението като работодател

Дисциплинарна (КТ)

Виновно неизпълнение на трудовите задължения (чл. 186, 187). Забележка, предупреждение за уволнение, уволнение (чл. 188). Изслушване преди наказание (чл. 193).

Имуществена (КТ)

При небрежност: до едно месечно възнаграждение, включително когато заведението е обезщетило пациента (чл. 206). При умисъл или престъпление: пълна (чл. 203, ал. 2).

Пострадалият търси обезщетение от лечебното заведение (ЗЗД, чл. 49); то има ограничен регрес срещу лекаря.

Казус 3 · Предаване без новия симптом

В края на дежурството си на 24 декември лекар чака закъсняващия колега почти час. Медицинска сестра съобщава за гръдна болка у пациент с пневмония. Лекарят назначава ЕКГ, но при бързото предаване забравя да спомене симптома. По-късно пациентът умира от остър миокарден инфаркт.

- Кои видове отговорност могат да възникнат и за кого?
- Какво трябва да се докаже за гражданската и за наказателната отговорност?
- Какъв е делът на организацията?

Доверието се гради в отношението, в екипа и
в институцията.

Законът очертава последиците, когато то бъде нарушено.